

Crohn Hastalığı

Çocuk ve ergende Crohn hastalığının tanısı, remisyon indüksiyonu, idame tedavisi ve dozla desteklenmiş izlem ilkeleri. Güncel ESPGHAN/ECCO ve porto kriterlerine dayanır.

EEN indüksiyon

Anti-TNF

Kalprotektin izlemi

Perianal hastalık

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Crohn hastalığı, ağızdan anüse kadar tüm gastrointestinal sistemi tutabilen, transmural ve segmental (atlamalı) tutulumla seyreden kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Çocuklarda sıklıkla ileokolonik tutulum ve büyüme geriliği ön plandadır. Tanı; klinik, laboratuvar, endoskopik, histolojik ve görüntüleme bulgularının bütünlüğüne (revize Porto kriterleri) dayanır; tek başına hiçbir test tanısal değildir.

Öykü

- Kronik ishal (>4 hafta), gece uyandıran karın ağrısı, rektal kanama
- Kilo kaybı, boy uzamasında duraklama, puberte gecikmesi
- Ateş, halsizlik, iştahsızlık; okul devamsızlığı
- Ekstraintestinal: artralji/artrit, aftöz stomatit, eritema nodozum, üveit
- Perianal semptomlar: ağrı, akıntı, fistül/apse öyküsü
- Aile öyküsü (İBH), erken başlangıç için monogenik İBH şüphesi (<6 yaş)

Muayene

- Antropometri: boy, kilo, VKİ persentil ve boy hızı (mutlaka)
- Solukluk, karın hassasiyeti/kitle, aftöz lezyonlar
- Perianal inspeksiyon: fissür, deri lifi (skin tag), fistül ağzı, apse
- Tanner evrelemesi ile puberte değerlendirmesi
- Çomak parmak, eklem bulguları, cilt/göz muayenesi
- Büyüme eğrisi geriye dönük gözden geçirilmeli

İlk başvuruda tanısal panel: tam kan sayımı, CRP, ESR, albümin, ferritin, karaciğer/böbrek fonksiyonları, fekal kalprotektin ve enfeksiyöz dışlama (dışkı kültürü, *C. difficile* toksini) mutlaka istenmelidir.

Şiddet sınıflaması (wPCDAI)

Pediyatrik Crohn hastalığı aktivitesi, kısaltılmış Pediyatrik Crohn Hastalığı Aktivite İndeksi (wPCDAI) ile derecelendirilir. Tedavi kararları ve yanıt izlemi bu skorlamaya göre yönlendirilir.

Remisyon

wPCDAI < 12,5

Semptomsuz; idame tedavisi ve mukozal iyileşme hedefi sürdürülür.

Hafif

wPCDAI 12,5–40

Hafif semptomlar; büyüme korunmuş. İndüksiyonda EEN öncelikli.

Orta

wPCDAI 40–57,5

Belirgin aktivite; EEN veya kortikosteroid + erken idame planı.

Ağır

wPCDAI > 57,5

Ağır aktivite / komplikasyon; erken anti-TNF (top-down) düşünülür.

Yüksek risk: derin ülser

Perianal fistül

Ağır büyüme geriliği

Yaygın panenterik tutulum

Striktür/penetrasyon

03 Karar akışı

Tanı doğrulandıktan sonra hastalık şiddeti, tutulum yaygınlığı ve risk faktörlerine göre indüksiyon ve idame stratejisi belirlenir.

BAŞLANGIÇ

Crohn tanısı doğrulandı (Porto kriterleri)

İleokolonoskopi + üst endoskopi + histoloji + MR enterografi ile tanı ve yaygınlık belirlendi.

ADIM 1

Şiddet ve risk katmanlandır

wPCDAI hesapla; yüksek riskli özellikleri (derin ülser, perianal hastalık, ağır büyüme geriliği, panenterik tutulum) belirle.

KARAR 1

Yüksek riskli/komplike hastalık veya aktif perianal fistül var mı?

Erken agresif (top-down) tedavi endikasyonu değerlendiriliyor.

EVET → Erken biyolojik

HAYIR → İndüksiyon

TOP-DOWN

Anti-TNF (infliksimab/adalimumab) başla

Perianal fistülize hastalıkta infliksimab + gerekirse cerrahi drenaj/seton. Erken TDM ile hedef düzey sağla.

STANDART İNDÜKSİYON

EEN 6–8 hafta (birinci basamak)

Luminal hafif–orta hastalıkta EEN önceliklidir; tolere edilemezse kortikosteroid. Eş zamanlı idame planla.

KARAR 2

İndüksiyon sonu (8–12. hafta) klinik + biyokimyasal remisyon sağlandı mı?

Klinik (wPCDAI), CRP normalizasyonu ve kalprotektin düşüşü birlikte değerlendirilir.

EVET → İdame

HAYIR → Basamak yükselt

İDAME

Tiyopürin veya metotreksat ile idame; mukozal iyileşme hedefi

STEP-UP

Anti-TNF'e geç; TDM ile optimize et

Yetersiz yanıtta biyolojik başla/optimize et; yanıtızlıkta ustekinumab/vedolizumab ve

Steroidsiz remisyonu sürdür; kalprotektin ve büyüme ile izle.

cerrahi konseyi değerlendir.

04 Basamaklı tetkik

Tanı, sistematik ve tam bir değerlendirme gerektirir; ince bağırsak görüntülemesi ve üst GİS endoskopisi çocuklarda zorunludur.

Crohn hastalığında tanısal basamaklar

BASAMAK	TETKİK	NOT
1. Laboratuvar	TKS, CRP, ESR, albümin, ferritin, KCFT, BUN/kreatinin	Anemi, trombositoz, hipoalbüminemi ve akut faz yüksekliği aktiviteyi destekler; normal olması tanıyı dışlamaz.
2. Dışkı	Fekal kalprotektin + enfeksiyöz panel	Kalprotektin yüksekliği inflamasyonu gösterir; kültür ve <i>C. difficile</i> toksini ile enfeksiyon dışlanır.
3. Endoskopi	İleokolonoskopi + özofagogastroduodenoskopi	Her iki uçtan çoklu biyopsi zorunlu; segmental tutulum, aftöz/derin ülser, kaldırım taşı görünümü aranır.
4. Histoloji	Biyopsi: transmural odak, non-kazeifiye granülom	Granülom Crohn için destekleyicidir; kript distorsiyonu, fokal kronik inflamasyon değerlendirilir.
5. Görüntüleme	MR enterografi (ince bağırsak)	Duvar kalınlaşması, striktür, penetran hastalık ve uzunluk değerlendirmesi; radyasyonsuz tercih.
6. Perianal	Pelvik MR ± muayene altında anestezi (EUA)	Fistül/apse şüphesinde pelvik MR altın standarttır; drenaj gereklyse EUA planlanır.
7. Tedavi öncesi	TPMT/NUDT15, latent TB (IGRA/PPD), HBV/VZV serolojisi	Tiyopürin ve anti-TNF öncesi güvenlik taraması; aşılama durumu gözden geçirilir.

Aşağıdaki bulgular acil değerlendirme, hospitalizasyon veya cerrahi konsültasyon gerektirir.

- Ağır GİS kanaması, hemodinamik instabilite veya derin anemi

- Akut ağır kolit; toksik megakolon bulguları (distansiyon, ateş, taşikardi)

- Bağırsak obstrüksiyonu / semptomatik striktür (safralı kusma, distansiyon)

- İntraabdominal veya perianal apse; sepsis bulguları

- Serbest perforasyon veya peritonit

- Belirgin büyüme durması / puberte gecikmesi

- Şiddetli malnütrisyon, dehidratasyon, elektrolit bozukluğu

- Biyolojik tedavi altında yeni/ilerleyici enfeksiyon işaretleri

İndüksiyonda beslenme tedavisi (EEN) önceliklidir; idamede immünomodülatör ve biyolojikler kullanılır. Dozlar kiloya göre ayarlanır ve maksimum erişkin dozu aşılmaz.

Crohn hastalığında ilaç/tedavi dozları	
TEDAVİ	DOZ
EEN (eksklüzif enteral beslenme)	Hedefin %100'ü, 6–8 hafta polimerik formül
Prednizolon (oral)	1 mg/kg/gün (maks 40 mg/gün)
Budesonid (ileoçekal)	9 mg/gün (hafif ileoçekal hastalık)
Azatioprin	2–2,5 mg/kg/gün
6-Merkaptopurin	1–1,5 mg/kg/gün
Metotreksat (SC)	15 mg/m ² /hafta (maks 25 mg/hafta)
İnfliksimab (IV)	5 mg/kg; 0-2-6. hafta indüksiyon, sonra her 8 haftada
Adalimumab (SC)	İndüksiyon 160/80 mg (<40 kg: 80/40 mg); idame ≥40 kg 40 mg,

TEDAVİ	DOZ
Ustekinumab	IV indüksiyon ~6 mg/kg, sonra SC 90 mg her 8 haftada
Vedolizumab	~6 mg/kg (maks 300 mg) IV; 0-2-6. hafta, sonra 8 haftada

Perianal fistülize hastalıkta anti-TNF tedavisi cerrahi (seton drenajı) ve gerektiğinde metronidazol/siprofloksasin ile kombine edilir. Aktif apse önce drene edilmelidir.

Tiyopürin ve anti-TNF kombinasyonunda, özellikle erkeklerde, nadir hepatosplenik T hücreli lenfoma riski akılda tutulmalı; tedavi süresi ve monoterapi seçenekleri bireysel değerlendirilmelidir.

Hedef sadece semptom kontrolü değil, biyokimyasal ve mukozal iyileşme ("treat-to-target") ile büyümenin korunmasıdır.

Aktivite ve laboratuvar izlemi

- Fekal kalprotektin: yanıt izlemi ve nüks öngörüsünde; indüksiyon sonrası ve idamede periyodik (ör. 3 ayda bir)
- CRP, TKS, albümin, ferritin ile inflamasyon ve beslenme durumu
- Klinik skor (wPCDAI) ile semptomatik takip
- Endoskopik yeniden değerlendirme mukozal iyileşmeyi doğrulamak için (ör. 6–12. ayda)

İlaç güvenliği ve TDM

- Anti-TNF için terapötik ilaç izlemi (TDM): dip düzey + anti-ilaç antikor; yetersiz yanıt/kayıpta reaktif ölçüm
- Tiyopürin: TKS ve KCFT ile miyelosupresyon/hepatotoksisite izlemi
- Latent TB, HBV reaktivasyonu izlemi; canlı aşılarda biyolojik öncesi tamamlanır
- Boy, kilo, VKİ persentili ve puberte her vizitte; kemik sağlığı ve D vitamini

Büyüme geriliği bağımsız bir tedavi başarısızlığı göstergesidir; boy hızında duraklama, kalprotektin/CRP normal olsa bile tedavi yoğunlaştırmayı gündeme getirmelidir. Psikososyal destek ve geçiş (transition) planı ergende ihmal edilmemelidir.

Kaynaklar

1. van Rheenen PF, Aloï M, Assa A, et al. The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohns Colitis. 2021.
2. Levine A, Koletzko S, Turner D, et al. ESPGHAN Revised Porto Criteria for the Diagnosis of Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014.
3. Turner D, Ricciuto A, Lewis A, et al. STRIDE-II: An Update on the Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE) Initiative. Gastroenterology. 2021.
4. Ruemmele FM, Veres G, Kolho KL, et al. Consensus Guidelines of ECCO/ESPGHAN on the Medical Management of Pediatric Crohn's Disease. J Crohns Colitis. 2014.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; bireysel hasta değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve klinik yargının yerini tutmaz. Dozlar doğrulanmalı ve yerel protokollere göre uyarlanmalıdır.